ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La régulation des naissances

PARTIE 01

Méthodes contraceptives naturelles

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · RÉGULATION DES NAISSANCES

La contraception par les *méthodes naturelles*

Comment un couple peut-il espacer les naissances sans recourir à des moyens médicaux ? Le corps de la femme suit un cycle bien réglé : savoir lire ce cycle, c'est déjà pouvoir agir sur la fécondation. Cette partie présente **6 notions** : la **définition de la contraception**, la **méthode Ogino** (ou du calendrier), la **méthode des températures**, le **coït interrompu**, l'**aménorrhée lactationnelle** (allaitement prolongé) et l'étude critique de leur **fiabilité**.

⏱ 20 min 🧬 6 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi réguler les naissances ?

01 Notion 1 · definition_contraception — Qu'est-ce que la contraception ?

02 Notion 2 · methode_ogino — La méthode du calendrier

03 Notion 3 · methode_temperatures — La méthode des températures

04 Notion 4 · coit_interrompu — Le coït interrompu

05 Notion 5 · amenorrhee_lactationnelle — Allaitement et aménorrhée

06 Notion 6 · fiabilite_methodes — Fiabilité et planification familiale

Pourquoi réguler les naissances ?

Dans les chapitres précédents, tu as appris comment un enfant est conçu : rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, fécondation, implantation. Mais un couple ne souhaite pas toujours un enfant **à chaque fois** : la santé de la mère, les ressources de la famille, l'éducation des enfants déjà nés sont autant de raisons d'**espacer les naissances**. La capacité à choisir le nombre d'enfants et le moment de leur venue s'appelle la **régulation des naissances**.

Les spécialistes de santé recommandent d'attendre **au moins 24 mois** entre deux naissances : cela laisse à la mère le temps de récupérer, limite l'anémie et l'épuisement, et donne à chaque enfant une meilleure attention et une meilleure alimentation. Au Niger, où la santé maternelle est une priorité de santé publique, la **planification familiale** est encouragée et expliquée dans les centres de santé, avec bienveillance et respect des choix de chaque famille.

UN ENJEU DE SANTÉ, PAS DE JUGEMENT

La régulation des naissances est un **problème de biologie et de santé publique**. Nous l'étudierons toujours avec le même regard : décrire les **mécanismes**, comparer l'**efficacité** des méthodes et signaler leurs **limites** — sans jamais juger les personnes.

Les méthodes se classent en deux grandes familles : les méthodes **naturelles** (cette partie), qui s'appuient sur la connaissance du cycle féminin ou sur des comportements, et les méthodes **artificielles** (partie 2), qui utilisent des moyens chimiques ou mécaniques. Commençons par poser la définition qui servira à tout le chapitre.

Qu'est-ce que la contraception ?

📖 DÉFINITION — LA CONTRACEPTION

La **contraception** est l'ensemble des moyens utilisés pour **empêcher la fécondation** (rencontre du spermatozoïde et de l'ovule), donc pour **éviter qu'une grossesse ne commence**. Elle s'oppose à la **contragestion** (ou contraception d'urgence), qui agit après un rapport à risque pour empêcher l'installation d'une grossesse.

Pour comprendre où chaque méthode intervient, rembobinons la chronologie de la procréation. Une grossesse ne peut débuter que si **toutes** ces étapes réussissent :

1. **Production des gamètes.** Le testicule produit des spermatozoïdes en continu ; l'ovaire libère un ovule à chaque cycle, au moment de l'**ovulation** (environ le 14e jour d'un cycle de 28 jours — voir le chapitre « régulation des organes génitaux »).

2. **Rencontre des gamètes.** Les spermatozoïdes, déposés dans les voies génitales féminines, survivent jusqu'à **3 jours** environ et remontent vers l'ovule.

3. **Fécondation.** Un spermatozoïde fusionne avec l'ovule dans la trompe : c'est la première cellule de l'embryon.

4. **Implantation (nidation).** L'embryon rejoint l'utérus et s'implante dans la muqueuse utérine (endomètre) : la grossesse est installée.

Une méthode contraceptive est efficace si elle **bloque au moins une de ces étapes** : empêcher l'ovulation (pilule), empêcher la rencontre des gamètes (préservatif, abstinence pendant la période fertile), ou gêner l'implantation (DIU). Chaque méthode naturelle que tu vas étudier cherche à empêcher la rencontre des gamètes — et c'est justement là que se cache leur limite commune : **elles ne bloquent rien mécaniquement**, elles demandent de la connaissance, de la discipline et la coopération constante du couple.

Contraception — empêcher la fécondation ou l'installation d'une grossesse, **avant** tout rapport.

Aménorrhée — absence de règles, qui traduit en général l'absence d'ovulation.

Période fertile — période du cycle pendant laquelle un rapport peut aboutir à une fécondation.

Fiabilité — probabilité qu'une méthode évite effectivement une grossesse en usage réel.

02 NOTION 2 · METHODE_OGINO

La méthode Ogino (méthode du calendrier)

📖 DÉFINITION — MÉTHODE OGINO

La **méthode Ogino** (ou méthode du calendrier) consiste à **s'abstenir de tout rapport sexuel pendant la période fertile** du cycle, calculée à partir des dates des cycles précédents. Elle repose sur le fait que l'ovulation a lieu **environ 14 jours avant les règles suivantes**, quelle que soit la longueur du cycle.

Prenons le cas de référence, un cycle régulier de **28 jours**. L'ovulation a lieu vers le **14e jour**. Mais la période fertile est **plus large que le jour de l'ovulation**, pour deux raisons biologiques :

les **spermatozoïdes survivent jusqu'à 3 jours**

dans les voies génitales féminines : un rapport du jour 11 peut féconder un ovule libéré le jour 14 ;

l' **ovule reste fécondable environ 24 heures**

après l'ovulation : un rapport du jour 15 peut encore aboutir.

La période fertile d'un cycle de 28 jours s'étend donc en pratique **du jour 10 au jour 17** environ (avec une marge de sécurité). C'est pendant cet intervalle que la méthode Ogino demande l'abstinence.

📊 EXEMPLE DE CALCUL — CYCLES IRRÉGULIERS

Quand les cycles varient, on observe les cycles sur plusieurs mois, puis on calcule avec les cycles **le plus court** et **le plus long** :

• premier jour fertile = durée du cycle le plus court − 18 jours ;

• dernier jour fertile = durée du cycle le plus long − 11 jours.

Exemple : cycles entre 26 et 32 jours → abstinence du **jour 26 − 18 = 8** au **jour 32 − 11 = 21**, soit 14 jours d'abstinence par cycle !

⚠️ POURQUOI LA MÉTHODE OGINO EST-ELLE PEU FIABLE ?

Tout repose sur une hypothèse fragile : que l'ovulation arrive **quand on l'a prédite**. Or la date d'ovulation **varie d'un cycle à l'autre** chez une même femme (stress, fatigue, maladie, alimentation). Une ovulation « retardée » ou « avancée » de quelques jours suffit à rendre la période calculée inefficace. Plus les cycles sont irréguliers, plus la méthode est incertaine.

🔍 UN PEU D'HISTOIRE

*Cette méthode porte le nom du médecin japonais **Kyasaku Ogino** qui, dans les années 1930, a précisé la date de l'ovulation dans le cycle ; le gynécologue autrichien Hermann Knaus en a fixé les règles de calcul. C'est l'une des plus anciennes méthodes de planification familiale fondées sur la biologie.*

La méthode des températures

Cette méthode, elle, ne devine plus l'ovulation : elle **l'observe**. Le corps de la femme laisse en effet une trace mesurable de son ovulation — dans sa température.

📖 PRINCIPE — LE LÉGER THERMIQUE

Après l'ovulation, le **corps jaune** se forme dans l'ovaire et sécrète de la **progestérone**. Cette hormone est **thermogène** : elle élève légèrement la température corporelle de la femme au repos (**température basale**) d'environ **0,3 à 0,5 °C**. Cette hausse durable, appelée **léger thermique**, signe que l'ovulation a déjà eu lieu.

Le protocole est simple à énoncer, mais exigeant à suivre. Il demande de la régularité jour après jour :

1. **Mesurer chaque matin**, au réveil, **avant toute activité** (même avant de se lever), la température à l'aide d'un thermomètre, et la noter sur un graphique.

2. **Repérer le léger thermique** : la courbe, stable en première partie de cycle, monte d'environ 0,3 à 0,5 °C et **reste élevée** jusqu'aux règles. Cette montée indique que l'ovulation a eu lieu la veille ou l'avant-veille.

3. **S'abstenir du 1er jour des règles jusqu'au 3e jour après la montée thermique** : pendant toute la première partie du cycle, on ne peut pas savoir quand l'ovulation viendra — le doute interdit les rapports.

4. **Reprendre les rapports après ce délai** : l'ovule n'est plus fécondable, et un nouveau cycle d'observation recommence aux règles suivantes.

Corps jaune → progestérone → température basale +0,3 à 0,5 °C (léger thermique)

La progestérone du corps jaune est l'« allumeuse » de la courbe thermique : pas de montée = pas d'ovulation passée = période potentiellement fertile.

⚠️ LES LIMITES DE LA MÉTHODE

La température basale est **sensible à bien des facteurs** : fièvre, infection, sommeil perturbé, alcool, chauffage de la chambre… Un léger thermique « trompeur » peut fausser l'observation. De plus, la méthode n'identifie l'ovulation qu'**après coup** : toute la première partie du cycle reste incertaine. Elle demande enfin une régularité quotidienne que la vie réelle rend difficile.

Tu remarques que cette méthode **mobilise directement le chapitre de régulation hormonale** : c'est la progestérone sécrétée par le corps jaune, sous le contrôle de la LH, qui élève la température. Un même mécanisme physiologique sert ici d'indicateur.

04 NOTION 4 · COIT_INTERROMPU

Le coït interrompu

📖 DÉFINITION — COÏT INTERROMPU

Le **coït interrompu** (ou retrait) consiste à **interrompre le rapport sexuel avant l'éjaculation**, de sorte que le sperme soit déposé à l'extérieur des voies génitales féminines. L'objectif est d'empêcher la rencontre des gamètes.

Le principe paraît simple ; en réalité, cette méthode cumule des faiblesses sérieuses, qui en font l'une des **moins fiables** :

Des spermatozoïdes peuvent être présents dans les sécrétions émises avant l'éjaculation

: le retrait ne garantit pas qu'aucun gamète mâle n'atteigne les voies génitales féminines.

Elle exige un contrôle parfait, à chaque rapport

: une seule fois où le retrait est trop tardif suffit. Le stress et l'émotion rendent ce contrôle difficile.

Aucune protection contre les IST et le SIDA

: le contact direct des muqueuses demeure.

Elle crée une tension dans le couple

, source d'échecs répétés et d'inconfort relationnel.

❌ ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne pas écrire que le coït interrompu « empêche la fécondation à coup sûr » ou qu'il « supprime tout contact entre gamètes ». La réponse attendue est : méthode **très peu fiable**, car des spermatozoïdes peuvent être émis **avant** l'éjaculation et parce que le retrait dépend d'un geste humain perfectible.

Allaitement maternel prolongé et aménorrhée lactationnelle

Voici une observation bien connue des sages-femmes : une femme qui allaite beaucoup n'a souvent **pas de règles** pendant plusieurs mois après l'accouchement, et ne retombe généralement pas enceinte durant cette période. Ce n'est pas une coïncidence — c'est de l'**endocrinologie**.

📖 DÉFINITION — AMÉNORRHÉE LACTATIONNELLE

L'**aménorrhée lactationnelle** est l'**absence d'ovulation (donc de règles)** provoquée par l'**allaitement maternel fréquent et prolongé**. La succion du sein stimule la sécrétion de **prolactine**, hormone qui **freine la libération de GnRH** par l'hypothalamus : sans GnRH, pas de FSH ni de LH, donc pas de maturation folliculaire ni d'ovulation.

1. **La tétée stimule le sein.** Chaque succion envoie un signal nerveux vers l'hypothalamus, le centre de commande hormonale du cerveau.

2. **L'hypophyse libère de la prolactine.** Cette hormone déclenche la production de lait — et agit aussi comme un **frein** sur la sécrétion de GnRH.

3. **FSH et LH restent basses.** Sans gonadostimulines, aucun follicule n'arrive à maturité :

   prolactine → ↓ GnRH → ↓ FSH/LH → pas d'ovulation.

4. **Résultat : aménorrhée.** Sans ovulation, pas de corps jaune, pas de chute de progestérone, pas de règles — et pas de grossesse possible tant que cet état persiste.

⚠️ UN EFFET RÉEL MAIS PARTIEL ET TEMPORAIRE

Cette protection **n'est pas absolue** : elle diminue quand les tétées deviennent moins fréquentes (diversification alimentaire, biberons), généralement après **quelques mois**. Or l'ovulation peut **revenir avant le retour des règles** : une femme peut donc ovuler sans s'en apercevoir. L'allaitement prolongé **espace** les naissances, mais il ne doit pas être considéré comme une contraception complète.

On revoit ici une architecture familière : un **rétrocontrôle négatif** (la prolactine freine la commande hypothalamo-hypophysaire), exactement comme la testostérone chez l'homme dans le chapitre sur la régulation des organes génitaux. Le même schéma logique, un autre contexte physiologique.

06 NOTION 6 · FIABILITE_METHODES

Fiabilité, limites et planification familiale

Réunissons les quatre méthodes naturelles et comparons-les froidement. Le tableau suivant est exactement le type de tableau attendu en commentaire de documents au Bac :

MÉTHODE NATURELLE	PRINCIPE	FIABILITÉ	LIMITES PRINCIPALES
Ogino (calendrier)	Abstinence pendant la période fertile calculée d'après les cycles précédents	Faible	Date d'ovulation variable d'un cycle à l'autre ; exige des cycles réguliers et une tenue rigoureuse des dates
Températures	Abstinence jusqu'au 3e jour suivant le léger thermique (progestérone)	Faible à moyenne	Température perturbée par la fièvre, le stress, le sommeil ; ovulation repérée seulement après coup
Coït interrompu	Retrait avant l'éjaculation	Très faible	Spermatozoïdes possibles dans les sécrétions antérieures ; dépend d'un contrôle humain parfait ; aucune protection IST
Allaitement prolongé	Prolactine → frein de GnRH → pas d'ovulation	Partielle, temporaire	Efficace seulement si les tétées sont très fréquentes ; l'ovulation peut revenir avant les règles

Trois enseignements se dégagent de ce tableau. Premièrement, **toutes les méthodes naturelles exigent une coopération constante du couple** : elles ne « fonctionnent » pas toutes seules, contrairement aux méthodes artificielles. Deuxièmement, **aucune ne protège contre les infections sexuellement transmissibles (IST) ni contre le SIDA** : c'est une limite commune et fondamentale. Troisièmement, leur intérêt principal tient à leur **accessibilité** : elles ne coûtent rien et ne demandent aucun produit — c'est pourquoi elles restent utilisées partout dans le monde, mais elles conviennent mal aux personnes dont les cycles sont irréguliers.

🌾 CONTEXTE NIGER — PLANIFICATION FAMILIALE ET SANTÉ MATERNELLE

Au Niger, l'espacement des naissances est un vrai sujet de santé publique : des grossesses trop rapprochées épuisent l'organisme maternel, aggravent l'anémie et réduisent le temps et les ressources consacrés à chaque enfant. Les **centres de santé** informent gratuitement les couples sur toutes les méthodes — naturelles et artificielles — afin que chacun choisisse **en connaissance de cause**, selon ses convictions et sa situation. La connaissance scientifique du cycle, que tu viens d'acquérir, est le fondement de toutes ces méthodes naturelles.

❌ ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne confonds pas **ovulation** (un instant précis : libération de l'ovule, vers le jour 14 d'un cycle de 28 jours) et **période fertile** (un intervalle d'environ une semaine, élargi par la survie des spermatozoïdes et de l'ovule). Les deux termes ne sont pas interchangeables : c'est la période fertile — pas le jour de l'ovulation — qui détermine l'abstinence dans la méthode Ogino.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans un cycle régulier de 28 jours, la méthode Ogino demande l'abstinence d'environ :

CORRECTION

du jour 10 au jour 17. La période fertile est élargie autour de l'ovulation (jour 14) : les spermatozoïdes survivent jusqu'à 3 jours avant, et l'ovule reste fécondable environ 24 h après. (D est le piège classique : confondre jour de l'ovulation et période fertile.)

Exercice 2

Le léger thermique de la méthode des températures est provoqué par :

CORRECTION

la progestérone du corps jaune, après l'ovulation. Cette hormone est thermogène : elle élève la température basale de 0,3 à 0,5 °C en seconde partie de cycle. (La FSH agit avant l'ovulation sur le follicule, mais n'élève pas la température.)

Exercice 3

L'aménorrhée lactationnelle s'explique par la chaîne :

CORRECTION

prolactine → ↓ GnRH → ↓ FSH/LH → pas d'ovulation. La succion fréquente du sein élève la prolactine, qui freine le centre hypothalamo-hypophysaire : aucun follicule n'arrive à maturité, donc pas d'ovulation. C'est un rétrocontrôle négatif, comme dans le chapitre de régulation hormonale.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ La régulation des naissances vise à **espacer les naissances** pour protéger la santé de la mère et celle des enfants ; elle se discute dans les centres de santé, avec respect des choix de chaque famille.
- ✓ **[definition_contraception]** La **contraception** est l'ensemble des moyens permettant d'**empêcher la fécondation** et donc l'installation d'une grossesse — elle agit **avant**, par opposition à la contraception d'urgence (partie 3).
- ✓ **[methode_ogino]** La méthode Ogino impose l'**abstinence pendant la période fertile** calculée d'après le cycle : pour un cycle de 28 jours, ovulation au jour 14, période fertile ≈ jours 10 à 17 (spermatozoïdes viables 3 jours, ovule 24 h).
- ✓ **[methode_ogino]** Elle est **peu fiable** car la date d'ovulation **varie d'un cycle à l'autre** — plus les cycles sont irréguliers, plus la méthode échoue.
- ✓ **[methode_temperatures]** Après l'ovulation, la **progestérone du corps jaune** élève la température basale de 0,3 à 0,5 °C (**léger thermique**) ; on s'abstient du 1er jour des règles jusqu'au 3e jour après la montée.

- ✓ **[methode_temperatures]** La courbe thermique est perturbée par la fièvre, le stress, le manque de sommeil — et elle n'indique l'ovulation qu'**après** qu'elle a eu lieu.

- ✓ **[coit_interrompu]** Le retrait avant l'éjaculation est une méthode **très peu fiable** : des spermatozoïdes peuvent être émis avant l'éjaculation, et le geste exige un contrôle parfait à chaque rapport.

- ✓ **[amenorrhee_lactationnelle]** L'allaitement maternel fréquent et prolongé maintient une sécrétion élevée de **prolactine**, qui freine la GnRH :

  prolactine → ↓ GnRH → ↓ FSH/LH → pas d'ovulation

  — effet réel mais **partiel et temporaire**.

- ✓ **[fiabilite_methodes]** Toutes les méthodes naturelles exigent la coopération constante du couple et **aucune ne protège contre les IST ni le SIDA** ; le tableau comparatif (principe, fiabilité, limites) est à savoir restituer.

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : quand la chimie et la mécanique prennent le relais — les méthodes contraceptives artificielles